

# Glande mammaire

## Plan du cours :

1. Introduction
  2. Anatomie descriptive
  3. Moyens de fixité
  4. Rapports
  5. Vascularisation
  6. Innervation
  7. Division clinique
- 

## **1. Introduction :**

La glande mammaire est l'organe de la lactation, c'est une glande exocrine, pair et lobulé, très développée chez la femme, rudimentaire chez l'homme et l'enfant, d'origine ectodermique, de morphologie très variable au cours de la vie génitale.

C'est une glande lactifère et sexuelle riche en neurorécepteurs et récepteurs hormonaux, sa fonction principale est de sécréter le lait nécessaire à l'alimentation du nouveau-né, elle joue aussi un rôle plastique fondamental chez la femme.

Sa pathologie est variable dominée par le cancer du sein.

## **2. Anatomie descriptive :**

### **2.1. Situation :**

La glande mammaire est contenue dans la mamelle (ou sein), elle est située sur la paroi ventrolatérale du thorax de part et d'autre du sternum, en avant des muscles pectoraux.

Elle est placée en regard de l'espace compris entre la 3<sup>e</sup> et la 7<sup>e</sup> côte.

Limitée en bas par le sillon infra mammaire très nette, et en haut par le sillon supra mammaire plus floue.

### **2.2. Forme**

La forme est variable selon les femmes, piriforme, conique, pédiculée, le plus souvent les seins sont légèrement asymétriques. La taille est variable selon les personnes.

### **2.3. Consistance :**

Le sein a une consistance un peu grenue, en comprimant le sein contre la paroi thoracique, la consistance devient ferme et élastique.

### **2.4. Dimensions :** sont très variable avec le degré d'activité glandulaire et selon les individus.

En moyenne : 10 cm de hauteur, 12 cm de largeur, 06 cm d'épaisseur.

La glande mammaire augmente de volume lors de la grossesse, de l'allaitement et en période prémenstruelle.

### **2.5. Configuration externe :**

On décrit 03 zones concentriques qui caractérisent le sein, du centre vers l'extérieur :

#### **2.5.1. La papille mammaire (ou mamelon) :**

C'est une saillie de forme cylindrique ou conique et parfois ombiliqué, pigmentée sauf au niveau du sommet qui est plus clair, elle mesure 10 mm de hauteur et 15 mm de largeur à sa base.

A son sommet se trouve une aire criblée (area cribrosa) qui correspond aux ostiums papillaires des conduits lactifères (10 à 20), ils sont disposés de façon circonférentielle.

## Glande mammaire

La face profonde du mamelon, est doublée par des fibres musculaires lisses constituant le muscle mamillaire dont la contraction est à l'origine du thélotisme ou érection du mamelon.

Le mamelon est latéral par rapport à la ligne médio claviculaire, il est disposé en regard ou au-dessous du 4<sup>e</sup> espace intercostal.

### 2.5.2. L'aréole :

C'est une zone cutanée annulaire pigmentée entourant la base du mamelon avec lequel elle se continue, de 35mm à 50mm de diamètre, de coloration brunâtre, plus foncée chez les bruns que chez les sujets blonds.

L'aréole est doublée à sa face profonde par le muscle de l'aréole.

Elle présente de petites éminences appelées les tubercules de Morgagni formées par de volumineuses glandes sébacées.

Sa peau est adhérente, immobile et richement innervée.

### 2.5.3. La peau péri aréolaire :

La peau est lisse, souple, fine, mobile et glisse facilement sur la glande. Glabre chez la femme et l'enfant, elle est revêtue d'un système pileux chez l'homme.

Des veines superficielles apparaissent chez la gestante ou la lactante.

## 2.6. Configuration interne :

- Chez l'homme et chez l'enfant la glande se réduit à un petit amas glandulaire blanchâtre, situé immédiatement en arrière de l'aréole.

- Chez la femme son aspect varie selon l'âge

\*Avant la puberté elle est réduite en amas cellulaire rétro aréolaire.

\*Lors de la puberté elle se développe et constitue une masse grossièrement arrondie de tissu glandulaire blanc bleuâtre, présentant :

- Une face postérieure plane, lisse et mobile sur le plan graisseux rétro mammaire.
- Une face antérieure convexe, présentant une série de crêtes qui donnent attache à des lamelles conjonctives du tissu cellulaire sous-cutané constituant les ligaments suspenseurs du sein (ligaments de Cooper).
- Une circonférence (à l'union des 02 faces) très irrégulière par la présence des prolongements.

\*Après la ménopause elle s'atrophie (fibrose).

## 2.7. Structure :

- La glande mammaire est développée dans un tissu adipeux, contenu dans un dédoublement du fascia superficiel du thorax formant les fascia pré et rétro mammaire.

- Elle est formée de lobes (10 à 20), ces lobes sont séparés par des travées conjonctives.

- Chaque lobe est formé de 20 à 40 lobules et chaque lobule contient 10 à 100 acini ou alvéoles qui sont l'unité sécrétrice de la glande.

- Chaque lobe possède son propre canal lactifère (canal galactophore) qui se dirige par un trajet sinueux vers le mamelon où il s'ouvre par un ostium.

- Le canal lactifère présente avant son engagement dans le mamelon une dilatation longue de 1 cm appelée le sinus lactifère.

## 3. Moyens de fixité :

Le sein, est solidaire de la peau, elle représente son principal soutien.

Les ligaments suspenseurs du sein (ligaments de Cooper) sont des amarres conjonctives suspendant la glande au plan cutané. Ils forment de nombreux septums qui unissent les fascias pré-mammaire et rétro-mammaire.

Chez la femme âgée les ligaments suspenseurs sont envahis de graisse, ils perdent alors leur valeur fonctionnelle.

## 4. Rapports :

Elle est en rapport en arrière avec ; De la superficie à la profondeur :

-L'espace rétro mammaire : cellulaire adipeux permettant le glissement de la glande et constitut un plan de clivage utile au chirurgien.

-Le muscle grand pectoral.

-Le muscle petit pectoral.

Glande mammaire

- Le gril costal avec les muscles intercostaux.
- La plèvre et le poumon.

## **5. Vascularisation :**

**5.1. Artères** : elles proviennent de 03 sources principales

**5.1.1. L'artère thoracique interne** : issue de la subclavière, donne les artères perforantes irrigant la partie interne de la glande.

**5.1.2. Les artères intercostales dorsales** : donnent des branches latérales qui perforent les muscles intercostaux, se ramifient en rameaux mammaires latéraux.

**5.1.3. L'artère axillaire** : donne au sein l'artère thoracique latérale, des rameaux thoraciques de l'artère thoraco-acromiale et l'artère thoracique suprême.

- Ces 03 sources alimentent un système anastomotique riche qui s'organisent en 03 réseaux : sous-dermique, pré-glandulaire et rétro- glandulaire.

## **5.2. Veines :**

- **Le réseau veineux profond** assure un drainage vers : les veines thoraciques internes, la veine axillaire, les veines intercostales.

- **Le réseau superficiel péri-mamelonnaire** particulièrement visible chez la gestante, tributaire des veines superficielles des régions voisines.

**5.3. Lymphatiques** : (leur importance est capitale en matière d'extension des cancers du sein)

- Réseau superficiel ou dermique se draine essentiellement dans les lymphocentres axillaires.
- Réseau profond ou de la glande mammaire est interlobulaire et intra lobaire, il se draine dans le réseau sous-aréolaire et dans les collecteurs rétro-mammaires.
- Réseau sous-aréolaire forme le centre anastomotique principal entre le réseau profond et superficiel.

Il y a deux types de collecteurs :

- Les collecteurs principaux se dirigent vers les ganglions axillaires
- Les collecteurs accessoires se dirigent vers les voies sus claviculaire, la voie mammaire interne et vers le sein opposé.

## **6. Innervation :**

- Innervation somatique : les branches cutanées du 3ème, 4èmes et 5èmes nerfs intercostaux, et les branches cutanées du plexus cervical superficiel.
- Innervation végétative les nerfs proviennent des parties cervicale et thoracique du tronc sympathique.

## **7. Division clinique :**

En pratique le sein est divisé en 04 quadrants centré par le mamelon : supéro-latéral, supéro-médial, inféro-latéral et inféro-médial.

Le siège le plus fréquent des tumeurs du sein est le quadrant supéro-latéral.

🌈 *La connaissance de la normale facilite la détection des signes anormaux, permettant un diagnostic précoce et une prise en charge efficace des problèmes potentiels.*

## **Références :**

BAQUE P, Manuel pratique d'anatomie, édition ELLIPSES.

BOUCHET A, CUILLERET J, Anatomie topographique descriptive et fonctionnelle, 2 le cou, le thorax, édition SIMEP

KAMINA P, Dos et thorax, édition MALOINE.

